

Síndrome febril prolongado o fiebre de origen desconocido

Bibliográfica 2022 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

TIPs 2021 – Módulo 14

PRONAP 2015 - módulo 3

Definiciones

FOD clásica (Petersdorf y Beeson – 1961)

Presencia de fiebre (temperatura $> 38,3^{\circ}\text{C}$), en un paciente adulto, de más de 3 semanas de evolución, de manejo ambulatorio o con 1 semana de evolución dentro del hospital, en donde luego del estudio adecuado no se pudo encontrar la causa.

FOD intrahospitalaria (Durack y Street - 1991)

Paciente hospitalizado que presenta fiebre ($> 38,3^{\circ}\text{C}$) en varias ocasiones, que no estaba presente ni se estaba incubando al momento del ingreso, y que sigue sin diagnóstico luego de 3 días de estudio adecuado de la fiebre con cultivos negativos.

FOD asociada a infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Paciente con infección por el VIH que presenta fiebre ($> 38,3^{\circ}\text{C}$) en varias ocasiones durante más de 4 semanas (ambulatorio) o más de 3 días (internado) en el que se desconoce su causa.

Fiebre recurrente o periódica

Si bien no existe un acuerdo global en la definición, se considera como 3 o más episodios de fiebre de duración variable (días a varias semanas) en 6 meses y con episodios separados con intervalos libres de enfermedad de al menos una semana.

En **pediatría** las definiciones de FOD son más variables y arbitrarias, pero las revisiones más recientes coinciden en definirla como la presencia de fiebre de al menos **7-10 días** de duración en la que, a pesar del estudio inicial, (anamnesis, examen físico completo y exámenes de laboratorio básicos), no se ha llegado a un diagnóstico definitivo.

Etiologías

- Las infecciones son las causas más frecuentes, principalmente las de origen viral: infecciones del tracto respiratorio y dentro de las bacterianas la ITU.
- Enfermedades del colágeno o reumatológicas (5 al 15% de los casos). Suelen afectar a niños mayores y adolescentes con fiebre de más de 3 a 4 semanas de duración. Entre las más frecuentes se encuentran la AIJ y LES, enfermedad de Kawasaki.
- Neoplasias (10% o menos de los casos), afectan con mayor frecuencia a niños mayores y adolescentes y la duración de la fiebre suele ser mayor a 3 semanas. En este grupo se destacan las leucemias, linfomas y tumores sólidos.
- Hasta un 30% de los casos de FOD pueden quedar sin diagnóstico etiológico a pesar de un estudio sistemático y minucioso.

“Banderas rojas” a tener en cuenta:

- Cambio de apetito
- Pérdida de peso
- Alteración del patrón del sueño
- Fiebre alta por más de 5 días, signos de foco
- Hepatoesplenomegalia,
- Palidez
- Presencia de petequias

La presencia de alguna de estas condiciones requiere la hospitalización del niño para continuar su estudio.

Orientación según examen físico

- Pérdida de peso

Nos hace pensar en un proceso crónico como la tuberculosis, la infección por el VIH, entre otros. Pero cuanto más crónica es la pérdida de peso, con posible compromiso de la talla, se aleja de las causas infecciosas.

- Inspección de piel y faneras

La presencia de petequias o lesiones hemorrágicas subungueales o esclerales nos orientan hacia una infección intravascular, endocarditis infecciosa.

- Fiebre y eritema ampollar o descamación

Se observan en los procesos infecciosos mediados por toxinas de bacterias como *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*.

- Linfadenopatía cervical con o sin faringitis o la presencia de visceromegalias
Asociada a la infección por el VEB, puede presentarse también en la enfermedad por arañazo de gato, infección por CMV, VIH, toxoplasmosis o neoplasias.

- Dolor facial, maxilar, mastoideo o frontal

Nos hace pensar en sinusitis y mastoiditis.

- Arritmias

Puede estar presente en la fiebre reumática.

- Aparición de un nuevo soplo cardíaco o la modificación de un soplo ya conocido

Puede ser un signo de endocarditis infecciosa.

- Presencia de infiltrados pulmonares recurrentes o crónicos

En malformaciones congénitas como secuestro pulmonar o bronquiectasias y adquiridos como la aspiración de cuerpo extraño.

Cuando estos infiltrados pulmonares se asocian a pérdida de peso y/o sudoración nocturna debemos sospechar tuberculosis.

- Presencia de visceromegalias, tumoraciones y dolor localizados en el abdomen

Pueden orientarnos a un absceso peri apendicular, hepático, infección pélvica o renal.

- Dolores musculares

Generalizados se pueden observar en miositis asociada a influenza. Mientras que los dolores localizados hacen sospechar miositis piógena.

- Dolor óseo puntual

Se presenta en la osteomielitis o en ciertos tumores. En niños pequeños tener en cuenta como agente causal *Kingella kingae*. En niños más grandes asociados a traumatismo el *Staphylococcus aureus*. Si hay derrame articular o compromiso inflamatorio podemos estar en presencia de una enfermedad autoinmune o reumatológica.

A- Laboratorio

Etapas 1

- Hemograma
- PCR
- VSG
- Enzimas hepáticas
- Albúmina
- LDH
- Ácido úrico
- Sedimento de orina
- Hemocultivos, urocultivo
- Serologías:
 - VEB
 - CMV
 - VIH,
 - Chagas

Etapas 2:

- Otros estudios serológicos según contexto epidemiológico:
 - Virus hepatitis A, B o C
 - *Bartonella henselae*
 - *Brucella*,
 - *Coxiella burnetii*
 - Toxoplasmosis
- Estudio de virus respiratorios en aspirado o hisopado nasofaríngeo
- *Mycoplasma*,
- Cultivo de fauces
- Considerar en áreas endémicas y FOD con infiltrados pulmonares:
 - Serología para micosis profundas como coccidioidomicosis, histoplasmosis.
 - Tuberculosis con examen directo y cultivo para BAAR) en muestras respiratorias (esputo o lavado gástrico).

Etapas 3

Si no se llega al diagnóstico se amplía los estudios con métodos invasivos.

- Estudio de médula ósea
- Biopsia de lesiones visibles o de otros materiales

B- Imágenes

También deben solicitarse de forma escalonada y dirigida según las hipótesis diagnósticas.

Radiografía de tórax

Solicitar en niños con FOD y síntomas respiratorios o en niños mayores con fiebre alta, leucocitosis con o sin síntomas respiratorios para hacer diagnóstico de neumonía oculta, para evaluar mediastino, visualizar la presencia de ganglios y ante sospecha de tuberculosis al paciente y a los padres. En estos casos se sugiere completar la evaluación con una TAC de tórax.

Ecografía abdominal

Útil para evaluar tumoraciones, colecciones y malformaciones. Si se sospecha de lesiones retroperitoneales o si hay dudas diagnósticas podría ser adecuado complementar con TAC de abdomen con y sin contraste.

Ecografía ginecológica

Solicitar en pacientes sexualmente activas o según hallazgos positivos al examen físico.

Ecocardiograma en pacientes con cardiopatía congénita, presencia de soplos, hemocultivos positivos o sospecha de enfermedad de Kawasaki.

TAC

Craneal, de senos paranasales y toracoabdominal con o sin contraste en caso de que los estudios ecográficos no sean concluyentes.

RMN

Tiene la desventaja de requerir sedación por el tiempo prolongado de estudio y no se encuentra disponible en todos los centros pediátricos. Y la ventaja de no irradiar al niño. Es el método de elección cuando se sospecha infección osteoarticular, para evaluar tejidos blandos, discos intervertebrales y elementos neurales, ante la sospecha de absceso epidural o presencia de lesiones del parénquima cerebral que no pueden definirse con TAC.

Tratamiento

Deben emplearse antitérmicos habituales para reducir el discomfort asociado al estado febril, **no** deben administrarse en forma reglada por el riesgo de modificar el curso natural de la fiebre.

Se recomienda evitar el uso empírico de antibióticos debido a que producen una disminución del rédito diagnóstico de los cultivos y otros medicamentos como corticoides que podrían retrasar el diagnóstico. Asimismo, el uso de antibióticos puede generar reacciones adversas que podrían agregar morbilidad al cuadro clínico.

Una excepción para el inicio empírico de antimicrobianos sería una alta sospecha de infección bacteriana o de tuberculosis en un paciente críticamente enfermo o con deterioro clínico, en quienes puede iniciarse el tratamiento a la espera de los resultados de estudios realizados.

Algoritmo

